



INFORME MÉDICO DE ATENCIÓN AMBULATORIA

Hospital General Dr. Enrique Garcés | Historia Clínica Única Automatizada (HCUA)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

N.º Historia Clínica:	HCU-2024-08471	N.º Cédula:	1712345678
Apellidos y Nombres:	VÁSQUEZ MORENO, ANA LUCÍA	Fecha de Nacimiento:	14/03/1985
Edad:	39 años	Sexo:	Femenino
Estado Civil:	Casada	Instrucción:	Superior
Ocupación:	Docente	Etnia:	Mestiza
Dirección:	Calle Gonzalo Zaldumbide N35-42 y Ladrón de Guevara, Quito		
Teléfono:	0987 654 321	Correo:	ana.vasquez@ejemplo.com
Representante / Contacto:	Carlos Vásquez – Esposo – 0991 234 567		
Alergias conocidas:	Penicilina (urticaria generalizada)	Tipo de Sangre:	O+

2. DATOS DE LA ATENCIÓN

Fecha de Atención:	08 de mayo de 2025	Hora:	10:45
Servicio / Especialidad:	Consulta Externa – Medicina Interna	Tipo de Consulta:	Primera vez
N.º Turno / Consulta:	CE-2025-00894	Médico Tratante:	Dr. Roberto Calderón Espinoza
Código Médico (SENESCYT):	1003-25-1847264	Cargo:	Médico Internista – Grado 3
Unidad Operativa:	Hospital General Dr. Enrique Garcés	Zona:	Zona 9 – Distrito Metropolitano de Quito
Financiamiento:	MSP – Atención Gratuita (Art. 362 Constitución)		

3. MOTIVO DE CONSULTA

Paciente acude por cuadro de **cefalea holocraneana de moderada intensidad** (EVA 6/10), acompañada de **fatiga persistente**, mareos ocasionales y **palpitaciones** de 3 semanas de evolución. Refiere además polidipsia, poliuria y pérdida de peso no intencional de aproximadamente 4 kg en el último mes.

4. ANTECEDENTES

PERSONALES PATOLÓGICOS	FAMILIARES	QUIRÚRGICOS / HOSPITALARIOS
------------------------	------------	-----------------------------



- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • Hipertensión arterial (dx. 2019) | • Madre: Diabetes Mellitus tipo 2 | • Apendicectomía (2004) |
| • Dislipidemia mixta (dx. 2021) | • Padre: HTA y enfermedad coronaria | • Cesárea (2010, 2015) |
| • Infección urinaria recurrente | • Hermano: Obesidad | • Sin hospitalizaciones recientes |

5. EXAMEN FÍSICO

SIGNOS VITALES Y ANTROPOMETRÍA

Tensión Arterial:	148 / 92 mmHg	Frecuencia Cardíaca:	88 lpm
Frecuencia Respiratoria:	18 rpm	Temperatura:	36.8 °C
Saturación O ₂ :	97 % (FiO ₂ 0.21)	Glucemia Capilar:	218 mg/dL
Peso:	74 kg	Talla:	1.62 m
IMC:	28.2 kg/m ² (Sobrepeso)	Perímetro Abdominal:	91 cm

Examen Regional: Paciente consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Facies álgica leve. Piel y mucosas hidratadas, normocoloreadas. **Cabeza y cuello:** normocéfala, sin adenopatías palpables. **Tórax:** simétrico, murmullo vesicular conservado bilateral, sin ruidos sobreañadidos. Ruidos cardíacos rítmicos, no se auscultan soplos. **Abdomen:** blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin visceromegalias. **Extremidades:** simétricas, sin edemas, pulsos periféricos presentes y simétricos. **Neurológico:** sin déficits focales.

6. DIAGNÓSTICO

#	DESCRIPCIÓN DIAGNÓSTICA	CIE-10	TIPO
1	Diabetes Mellitus tipo 2 – debut (a confirmar)	E11.9	Presuntivo
2	Hipertensión arterial esencial, no controlada	I10	Definitivo
3	Cefalea tensional	G44.2	Definitivo
4	Dislipidemia mixta	E78.2	Definitivo
5	Sobrepeso (IMC 28.2)	E66.09	Definitivo

7. PLAN TERAPÉUTICO Y PRESCRIPCIÓN

N.º	MEDICAMENTO (DCI)	PRESENTACIÓN	DOSIS	VÍA	FRECUENCIA	DURACIÓN
1	Metformina	Tab. 850 mg	850 mg	VO	c/12h c/comida	30 días
2	Amlodipino	Tab. 5 mg	5 mg	VO	c/24h (noche)	30 días
3	Enalapril	Tab. 10 mg	10 mg	VO	c/12h	30 días
4	Atorvastatina	Tab. 20 mg	20 mg	VO	c/24h (noche)	30 días
5	Paracetamol	Tab. 500 mg	500 mg	VO	c/8h SOS	5 días

Indicaciones y recomendaciones:

- Control glucémico domiciliario en ayunas y 2 horas postprandial. Registrar valores en libreta.
- Dieta hipocalórica, baja en carbohidratos simples y sodio (<2 g/día). Evitar bebidas azucaradas.
- Actividad física aeróbica mínimo 150 minutos/semana (caminata moderada).
- No suspender medicación antihipertensiva. Consultar si PA > 160/100 mmHg.
- Retornar a control en 15 días con resultados de exámenes solicitados.



6. Acudir a Emergencias si presenta: visión borrosa, dolor torácico, disnea, cefalea intensa.

8. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS

LABORATORIO	CÓDIGO	PRIORIDAD
Hemograma completo (BHC)	LAB-001	Urgente
Glucosa en ayunas	LAB-012	Urgente
HbA1c (Hemoglobina glicosilada)	LAB-018	Rutina
Perfil lipídico completo (CT, HDL, LDL, TG)	LAB-031	Rutina
Función renal: creatinina, BUN, ácido úrico	LAB-045	Rutina
Función hepática: TGO, TGP, GGT, FA	LAB-052	Rutina
Orina completa con sedimento	LAB-071	Urgente
Microalbuminuria en orina de 24 horas	LAB-079	Rutina
ECG de 12 derivaciones	ECG-001	Urgente
Fondo de ojo (interconsulta Oftalmología)	IC-OFT-001	Programado

Dr. Roberto Calderón Espinoza

Médico Internista – Reg. SENESCYT 1003-25-1847264

Hospital General Dr. Enrique Garcés – MSP

Ana Lucía Vásquez Moreno

Cédula: 1712345678

Firma del Paciente / Representante

Nota Legal: El presente informe médico ha sido emitido de conformidad con el Art. 12 de la Ley Orgánica de Salud y el Acuerdo Ministerial N.º 00001365-A. La información contenida es de carácter confidencial y está protegida por el secreto médico conforme al Art. 74 del Código de Ética Médica. Cualquier alteración o uso indebido de este documento constituye infracción sancionada por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), Art. 327.